

# REVISÃO OSCE

## Semiologia Médica

Exame Físico · Sinais Vitais · Síndromes Clínicas

Monitor(a): \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_



# Exame Físico Geral, Sinais Vitais e HAS

Técnica de aferição · Critérios diagnósticos · Classificação · Lesões de órgão-alvo

# Sinais Vitais — Técnica e Valores de Referência

## Pressão Arterial

- Posição sentada, braço apoiado na altura do coração, em repouso  $\geq 5$  min
- Manguito adequado: largura = 40% da circunferência do braço
- Insuflação até 20–30 mmHg acima do desaparecimento do pulso radial
- Deflação: 2–3 mmHg/s
- Ruído de Korotkoff I = PAS; fase V (desaparecimento) = PAD
- Confirmar em 2 visitas com  $\geq 2$  medidas cada
- Normal: PAS < 120 e PAD < 80 mmHg

## Demais Parâmetros

- FC: palpação radial por 60 s | Normal: 60–100 bpm
- FR: observação do tórax por 60 s (sem avisar) | Normal: 12–20 irpm
- Temperatura axilar: 36,0–36,9°C | oral: +0,5°C | retal: +1°C
- SpO<sub>2</sub>: oximetria de pulso | Normal:  $\geq 95\%$
- Glicemia capilar: jejum < 100 mg/dL
- Peso/IMC: avaliar sobrepeso (25–29,9) e obesidade ( $\geq 30$ )

## HAS — Classificação pela Diretriz Brasileira (2020)

| Categoria             | PAS (mmHg) |      | PAD (mmHg) |
|-----------------------|------------|------|------------|
| Ótima                 | < 120      | e    | < 80       |
| Normal                | 120–129    | e/ou | < 80       |
| Pré-HAS               | 130–139    | e/ou | 80–89      |
| HAS Estágio 1         | 140–159    | e/ou | 90–99      |
| HAS Estágio 2         | 160–179    | e/ou | 100–109    |
| HAS Estágio 3         | ≥ 180      | e/ou | ≥ 110      |
| HAS Sistólica Isolada | ≥ 140      | e    | < 90       |

# HAS — Exame Físico e Lesões de Órgão-Alvo (LOA)

## Exame Físico Dirigido

- Fundo de olho: cruzamentos patológicos A-V, hemorragias, exsudatos, papiledema (Classificação de Keith-Wagener)
- Cardiovascular: hiperfonese de B2 em foco aórtico, B4, sopros (insuficiência aórtica), deslocamento do ictus cordis (HVE)
- Pulsos: assimetria, déficit, retardo radio-femoral
- Palpação abdominal: sopros renais, hepatomegalia
- Exame neurológico: déficits focais

## Exames para Investigação Inicial

- Hemograma, glicemia, lipidograma, ácido úrico
- Creatinina + TFG<sub>e</sub> (MDRD ou CKD-EPI)
- Potássio sérico
- EAS + microalbuminúria
- Eletrocardiograma (12 derivações)
- Raio-X tórax PA (se suspeita de IC)
- Ecocardiograma (se ECG alterado ou sintomas)
- Fundoscopia (se HAS grave ou DM)



## SIMULAÇÃO 1 — Caso Clínico

**CASO:** JFS, 58 anos, masculino, comparece à UBS para consulta de rotina. Assintomático. Ex-tabagista. Ao exame: PA = 162/98 mmHg (braço direito), FC = 82 bpm, FR = 16 irpm, IMC = 29,8 kg/m<sup>2</sup>. Exame neurológico sem déficits focais.

### O que o examinador pode pedir:

1. Demonstre a técnica CORRETA de aferição da PA (posicionamento, manguito, desinsuflação).
2. Classifique a HAS segundo a diretriz vigente.
3. Quais achados do exame físico você ainda pesquisaria para identificar LOA?
4. Solicite os exames complementares da investigação inicial.
5. Quais perguntas complementares faria para completar a anamnese? (história familiar, uso de medicamentos, sal, álcool, atividade física)



# Insuficiência Cardíaca

Critérios de Framingham · Exame físico baseado em evidências · Classificação NYHA

# IC — Critérios de Framingham

## Critérios Maiores

- Dispneia paroxística noturna (DPN)
- Ingurgitamento jugular
- Crepitações pulmonares
- Cardiomegalia ao RX
- Edema pulmonar agudo
- Galope (B3)
- Refluxo hepatojugular
- Pressão venosa central  $> 16 \text{ cmH}_2\text{O}$
- Perda de peso  $\geq 4,5 \text{ kg}$  em 5 dias com tratamento

## Critérios Menores

- Edema bilateral de tornozelos
- Tosse noturna
- Dispneia ao esforço
- Hepatomegalia
- Derrame pleural
- Redução da CVF em 1/3
- Taquicardia ( $\text{FC} \geq 120 \text{ bpm}$ )
- Diagnóstico: 2 maiores OU 1 maior + 2 menores

# IC — Achados ao Exame Físico

## Alta sensibilidade para IC descompensada

- Dispneia (sens. 66%, esp. 52%)
- Ortopneia (sens. 44%, esp. 89%)
- Crepitações pulmonares (sens. 60%, esp. 78%)
- Edema de membros inferiores (sens. 50%, esp. 78%)
- Ingurgitamento jugular (sens. 39%, esp. 92%): avaliar a 45° com incidência lateral, identificar ponto de colapso
- Refluxo hepatojugular: pressão por 10 s no QSD — positivo se jugular ingurge  $\geq 3$  cm
- B3 (galope protodiastólico): alta especificidade para IC com fração de ejeção reduzida

## Classificação NYHA

- Classe I: Sem limitação — atividades habituais não causam sintomas
- Classe II: Limitação leve — atividades habituais causam sintomas; assintomático em repouso
- Classe III: Limitação acentuada — atividades menos que habituais causam sintomas; assintomático em repouso
- Classe IV: Sintomas em repouso ou a mínimos esforços
- Exames-chave: BNP/NT-proBNP, ecocardiograma (FE), RX tórax (ceifose, linhas B de Kerley, redistribuição vascular)



## SIMULAÇÃO 2 — Caso Clínico

**CASO:** MRA, 72 anos, feminino, hipertensa e diabética há 20 anos. Internação por dispneia progressiva há 1 semana, piora em decúbito, tossindo à noite. Ao exame: PA 150/94, FC 106 bpm, SpO<sub>2</sub> 91%, crepitações bibasais, TVJ positiva, edema de MMII (++)/4+).

### O que o examinador pode pedir:

1. Aplique os critérios de Framingham e classifique a gravidade pela NYHA.
2. Quais achados do exame físico você buscaria para confirmar congestão pulmonar e sistêmica?
3. Como realizar e interpretar o refluxo hepatojugular?
4. Quais perguntas complementares faria sobre ortopneia e DPN?
5. Solicite os exames pertinentes e justifique cada um.



# Aspectos Clínicos das Coronariopatias

Angina · SCA · Apresentações atípicas · ECG

# Coronariopatias — Apresentação Clínica

## Angina Estável

- Dor/desconforto retroesternal em aperto ou pressão
- Irradiação: MSE, mandíbula, epigástrio
- Duração: 2–10 min; alivia com repouso ou nitrato
- Precipitada por esforço, emoção, frio
- Classificação CCS (I–IV) conforme limiar de esforço

## SCA (Síndrome Coronariana Aguda)

- Angina Instável: angina em repouso, de início recente ou em crescendo SEM elevação de troponina
- IAMSSST: angina em repouso + troponina elevada, SEM supradesnivelamento de ST
- IAMCSST: dor prolongada > 20 min + supradesnivelamento de ST  $\geq 1$  mm (2 mm em V1–V3) + troponina elevada
- Apresentação atípica (mulheres, idosos, DM): epigastralgia, náusea, fadiga, dispneia isolada

# Coronariopatias — ECG e Exame Físico

## Achados ao ECG

- Angina estável: pode ser normal em repouso
- IAM com supra: supradesnivelamento ST  $\geq 1$  mm (V1-V3:  $\geq 2$  mm), onda Q patológica ( $> 40$  ms,  $> 1/4$  do QRS)
- Localização: anterior (V1-V4), lateral (V5-V6, I, aVL), inferior (II, III, aVF), posterior (espelho em V1-V2)
- IAMSSST: infradesnivelamento ST  $\geq 0,5$  mm ou inversão de onda T
- Posicionamento correto dos eletrodos: V1 (4º EIC para-esternal D), V2 (4º EIC para-esternal E), V3 (entre V2 e V4), V4 (5º EIC LMC), V5 (LAA), V6 (LAM)

## Exame Físico e Escores de Risco

- B3 ou B4 na vigência de dor (disfunção ventricular aguda)
- Sopro de insuficiência mitral aguda (isquemia do músculo papilar)
- Hipotensão + bradicardia = IAM inferior (reflexo de Bezold-Jarisch)
- TIMI Risk Score (AI/IAMSSST): idade  $\geq 65$ ,  $\geq 3$  FRC, estenose prévia, desvio ST,  $\geq 2$  episódios em 24h, uso de AAS, troponina elevada
- GRACE Score: considera FC, PA, creatinina, classe Killip, parada cardíaca, desvio ST, troponina



## SIMULAÇÃO 3 — Caso Clínico

**CASO:** RLP, 62 anos, hipertenso, diabético, tabagista. Dor retroesternal intensa em aperto, irradiação para MSE, início há 50 minutos, não alivia com repouso. Sudorese fria, PA 130/85 mmHg, FC 98 bpm.

### O que o examinador pode pedir:

1. Como você posicionaria os eletrodos para realizar o ECG de 12 derivações? Descreva o passo a passo.
2. Quais achados no ECG seriam esperados para IAMCSST de parede inferior?
3. Calcule o TIMI Risk Score para este paciente.
4. Quais perguntas adicionais você faria para completar a história de dor torácica?
5. Solicite os exames de urgência e liste as medidas iniciais (MONA modificado).



# Manifestações Clínicas das Valvopatias

Estenose e insuficiência mitral e aórtica · Sopros · Sinais periféricos

# Valvopatias — Estenose e Insuficiência Mitral

## Estenose Mitral (EM)

- Etiologia: sequela reumática (principal)
- Sopro: ruflar diastólico em foco mitral (rumble), melhor com decúbito lateral esquerdo e sino do estetoscópio
- B1 hiperfonética + estalido de abertura mitral
- Fácies mitralica: cianose malar bilateral
- Complicações: FA, hipertensão pulmonar, embolias sistêmicas
- Pulso: parvus (débito reduzido)
- Sinais de HP: B2 hiperfonética em foco pulmonar

## Insuficiência Mitral (IM)

- Etiologia: prolapso da valva mitral (mais comum no mundo), reumática, isquêmica
- Sopro: holossistólico em foco mitral com irradiação para axila
- Característica: não altera com a respiração
- B3 (regurgitação volumosa)
- Achados de IC no exame (dispneia, crepitações, TVJ)
- Prolapso mitral: click mesossistólico + sopro telediastólico; piora em posição ortostática

# Valvopatias — Estenose e Insuficiência Aórtica

## Estenose Aórtica (EA)

- Tríade clássica: síncope, angina, dispneia
- Sopro: ejetivo mesossistólico (crescendo-decrescendo) no foco aórtico (2° EIC para-esternal D), com irradiação para carótidas
- Pulso parvus et tardus (pequeno amplitude e ascenso lento)
- B2 hipofonética ou abolida (imobilidade da valva)
- Frêmito sistólico em foco aórtico
- Apex deslocado (HVE excêntrica na EA grave)

## Insuficiência Aórtica (IA)

- Etiologia: febre reumática, bicúspide, endocardite, aortite sifilítica
- Sopro: diastólico em decrescendo em foco aórtico acessório (3° EIC para-esternal E), melhor com paciente sentado inclinado à frente
- Pulso em martelo d'água (Corrigan): ascenso rápido e colapso súbito
- Pressão de pulso alargada (PAS elevada, PAD baixa)
- Sinal de Musset: movimento de balanceio da cabeça
- Sinal de Quincke: pulsação capilar nas unhas
- Sinal de Duroziez: sopro bidirecional à compressão da femoral



## SIMULAÇÃO 4 — Caso Clínico

**CASO:** BCS, 45 anos, feminino, com antecedente de febre reumática na infância. Queixa de dispneia progressiva e palpitações. Ao exame: pulso irregular, B1 hiperfonética, estalido de abertura, ruflar diastólico em foco mitral, FC 110 bpm, PA 100/70 mmHg.

### O que o examinador pode pedir:

1. Qual a valvopatia mais provável? Descreva as características semiológicas do sopro encontrado.
2. Como posicionar o paciente para melhor ausculta do sopro desta valvopatia?
3. Quais complicações você pesquisaria neste caso (sinais de FA e tromboembolismo)?
4. Quais outras valvopatias você investigaria no exame físico por serem frequentemente associadas?
5. Solicite os exames e justifique o papel do ecocardiograma.



# Manifestações Clínicas da DAOP

Doença Arterial Obstrutiva Periférica • Classificação de Fontaine • Índice Tornozelo-Braquial

# DAOP — Clínica e Classificação de Fontaine

## Manifestações Clínicas

- Claudicação intermitente: dor muscular em MMII desencadeada pelo esforço, alivia com repouso (< 10 min)
- Distância de marcha útil: distância percorrida até início da dor
- Dor em repouso: queimação na região plantar, piora decúbito, melhora com perna pendente
- Lesões isquêmicas: úlcera de ponta de dedo, gangrena seca
- Diferença DAOP x venosa: úlcera dolorosa, bordas irregulares, local: polpa distal/maléolo lateral
- FRC principais: tabagismo, DM, HAS, dislipidemia

## Classificação de Fontaine

- Estágio I: Assintomático (achado incidental – ITB < 0,9)
- Estágio IIa: Claudicação intermitente leve (> 200 m)
- Estágio IIb: Claudicação intermitente moderada-grave (< 200 m)
- Estágio III: Dor isquêmica em repouso
- Estágio IV: Lesões tróficas (úlcera isquêmica ou gangrena)
- Estágios III e IV = isquemia crítica dos membros

# DAOP — Índice Tornozelo-Braquial (ITB) — Técnica e Interpretação

- Material necessário: doppler vascular portátil + esfigmomanômetro
- Passo 1: Paciente em decúbito dorsal por 10 min
- Passo 2: Medir PA sistólica no braço direito com doppler sobre a artéria braquial
- Passo 3: Medir PA sistólica no tornozelo (artéria tibial posterior e pediosa dorsal) bilateralmente
- Cálculo:  $ITB = \text{maior PAS tornozelo} \div \text{maior PAS braquial}$
- $ITB > 1,3$ : calcificação arterial (DM, DRC) — não diagnóstico
- $ITB 1,0-1,3$ : normal
- $ITB 0,9-1,0$ : limítrofe
- $ITB 0,7-0,9$ : DAOP leve
- $ITB 0,4-0,7$ : DAOP moderada
- $ITB < 0,4$ : DAOP grave / isquemia crítica
- Exames complementares: duplex scan, angiotomografia, arteriografia



## SIMULAÇÃO 5 — Caso Clínico

**CASO:** MFS, 65 anos, tabagista há 40 anos, diabético. Refere dor nas panturrilhas ao caminhar cerca de 150 metros, com alívio após 5 min de repouso. Ao exame: pulsos pediosos diminuídos bilateralmente ( $D > E$ ), sem lesões cutâneas. Pela semiologia abdominal, há frêmito em aorta abdominal.

### O que o examinador pode pedir:

1. Classifique o paciente segundo Fontaine com base no quadro clínico.
2. Demonstre como realizar o ITB: técnica, medidas e cálculo.
3. Interprete um ITB de 0,62 no membro direito e 0,55 no esquerdo.
4. Quais perguntas adicionais você faria para diferenciar claudicação neurogênica de vascular?
5. Solicite os exames de imagem pertinentes.



# TEV e Insuficiência Venosa Periférica

TVP · TEP · Score de Wells · Classificação CEAP

# Trombose Venosa Profunda — Clínica e Score de Wells

## Manifestações Clínicas

- Edema unilateral de MMII (assimetria > 3 cm entre as panturrilhas)
- Dor e sensibilidade à palpação no trajeto venoso
- Empastamento da panturrilha
- Eritema, calor e cianose local
- Sinal de Homans: dor à dorsiflexão passiva do pé (baixa especificidade)
- Sinal de Bancroft: dor à compressão da panturrilha contra a tíbia
- TVP iliofemoral: síndrome de phlegmasia cerulea dolens (edema massivo, cianose)

## Score de Wells para TVP

- +1 Neoplasia ativa
- +1 Paralisia ou imobilização de MMII
- +1 Acamado  $\geq 3$  dias OU cirurgia nas últimas 12 sem.
- +1 Dor em trajeto venoso profundo
- +1 Edema unilateral de toda a perna
- +1 Edema da panturrilha  $\geq 3$  cm vs contralateral
- +1 Edema depressível restrito à perna sintomática
- +1 Veias superficiais colaterais (não varicosas)
- -2 Diagnóstico alternativo tão ou mais provável
- $\geq 2$ : alta probabilidade | 1: moderada |  $\leq 0$ : baixa

# TEP — Clínica e Insuficiência Venosa Periférica

## TEP — Apresentação e Score de Wells

- Tríade clássica: dispneia súbita + dor pleurítica + hemoptise (rara)
- Síncope, taquicardia, hipotensão (TEP maciço)
- Score de Wells TEP: TVP clínica (+3), FC > 100 (+1,5), imobilização/cirurgia (+1,5), TVP/TEP prévio (+1,5), hemoptise (+1), neoplasia (+1), diagnóstico alternativo menos provável (+3)
- < 2 pts: baixa prob. | 2-6: moderada | > 6: alta
- D-dímero: valor preditivo negativo alto (exclui em baixa probabilidade)
- Angiotomografia: exame confirmatório de escolha

## Insuficiência Venosa — Classificação CEAP

- C0: Sem sinais visíveis ou palpáveis
- C1: Telangiectasias ou veias reticulares
- C2: Varizes (> 3 mm de diâmetro)
- C3: Edema
- C4a: Alterações cutâneas (eczema, hiperpigmentação)
- C4b: Lipodermatoesclerose, atrofia branca
- C5: Úlcera cicatrizada
- C6: Úlcera venosa ativa
- Úlcera venosa: medial, bordas irregulares, fundo com granulação, dor leve, edema associado



## SIMULAÇÃO 6 — Caso Clínico

**CASO:** LCS, 38 anos, feminino, pós-operatório de 10 dias de artroplastia de quadril. Queixa de dor e edema na panturrilha esquerda há 2 dias. Ao exame: edema de MIE com empastamento, diferença de 4 cm na circunferência das panturrilhas, sem eritema. SpO<sub>2</sub> 95%, FC 102 bpm.

### O que o examinador pode pedir:

1. Calcule o score de Wells para TVP e classifique a probabilidade clínica.
2. Quais sinais semiológicos você pesquisaria (Homans, Bancroft, Sigg)?
3. Há dados que sugiram TEP associado? Calcule o Wells para TEP.
4. Solicite os exames na sequência correta (D-dímero, duplex, angioTC).
5. Quais perguntas complementares fariam parte da sua anamnese?



# Tuberculose Pulmonar e Extrapulmonar

Epidemiologia · Clínica · Diagnóstico · Formas extrapulmonares

# TB Pulmonar — Clínica e Diagnóstico

## Manifestações Clínicas

- Tosse  $\geq 3$  semanas (principal sintoma — sintomático respiratório)
- Hemoptise (de estrias a franca)
- Síndrome constitucional: febre vespertina, sudorese noturna, perda ponderal ( $> 10\%$  do peso)
- Dispneia: formas extensas ou pleurite associada
- RX tórax: infiltrado pulmonar com predomínio em lobos superiores (ápices), cavitações, nódulos, fibrose, calcificações
- BAAR: baciloscopia de escarro (2 amostras) — positiva em  $\sim 80\%$  dos pulmonares bacilíferos
- Teste molecular (GeneXpert MTB/RIF): diagnóstico rápido + resistência à rifampicina

## Diagnóstico e Rastreio

- PPD (Prova Tuberculínica):  $\geq 5$  mm em imunocomprometidos,  $\geq 10$  mm em geral
- IGRA (interferon-gama): ILTB em imunocomprometidos
- Lavado brônquico/broncoaspirado: quando escarro impossível
- Cultura de BAAR: padrão-ouro (6–8 sem.) + TSA
- Definição de caso: clínico-epidemiológico OU bacteriológico
- Critérios de notificação compulsória imediata
- Brasil: 3º maior número de casos nas Américas

# TB Extrapulmonar — Principais Formas

## TB Pleural e Ganglionar

- TB Pleural: forma extrapulmonar mais comum no Brasil
- Derrame pleural exsudativo ( $\text{pH} < 7,3$ , glicose baixa, LDH elevada, predomínio linfocitário)
- ADA (adenosina deaminase) no líquido pleural  $\geq 40$  U/L: alta sens./esp.
- Biópsia pleural: granuloma caseoso em ~70%
- TB Ganglionar: adenomegalia cervical indolor, consistência borrachosa, coalescente, pode fistulizar (escrófula)

## Outras Formas

- TB Meníngea: meningite de instalação subaguda (1–2 semanas), LCR com pleocitose linfocitária, glicose baixa, proteína elevada; BAAR no LCR positivo em apenas 10–40%
- TB Óssea (Mal de Pott): acometimento de corpos vertebrais (D10-L2), gibosidade, dor lombar, possível déficit neurológico
- TB Miliar: disseminação hematogênica; RX tórax com padrão milionário (micronódulos difusos); BAAR raramente positivo
- TB Urinária: piúria estéril, hematúria, disúria; EAS com leucocitúria sem bactérias — pesquisa de BAAR na urina



## SIMULAÇÃO 7 — Caso Clínico

**CASO:** PAS, 28 anos, masculino, HIV positivo há 2 anos ( $CD4 = 180$  células/ $mm^3$ ). Tosse há 6 semanas com hemoptise esporádica, febre vespertina, perda de 8 kg em 2 meses. Ausculta pulmonar: murmúrio vesicular abolido na base direita.

### O que o examinador pode pedir:

1. Quais perguntas adicionais você faria para ampliar a investigação de TB?
2. Qual a hipótese diagnóstica? Qual forma de TB você suspeitaria pela ausculta?
3. Solicite os exames prioritários para este imunocomprometido (baciloscopia, BAAR, GeneXpert, ADA).
4. Como interpretar o PPD neste paciente com HIV?
5. Notificação compulsória: quando e como deve ser feita?



# DPOC e Fibrose Pulmonar Idiopática

Classificação GOLD · Fenótipos · Padrão restritivo × obstrutivo

# DPOC — Clínica e Classificação GOLD

## Fenótipos Clínicos

- Pink Puffer (Enfisematoso): magro, dispneico grave, tosse escassa, tórax em tonel, hiperfonese, uso de musculatura acessória, respira com lábios franzidos
- Blue Bloater (Bronquítico crônico): obeso/sobrepeso, cianose, tosse produtiva  $\geq 3$  meses/ano por  $\geq 2$  anos consecutivos, sibilos, edemas — hipoxemia crônica
- Exame físico: hiperinsuflação, redução do murmúrio vesicular, prolongamento do tempo expiratório, roncos e sibilos

## Classificação GOLD (Espirometria)

- Critério:  $VEF_1/CVF < 0,70$  pós-broncodilatador
- GOLD 1 (Leve):  $VEF_1 \geq 80\%$  do predito
- GOLD 2 (Moderada):  $VEF_1 50-79\%$
- GOLD 3 (Grave):  $VEF_1 30-49\%$
- GOLD 4 (Muito grave):  $VEF_1 < 30\%$
- mMRC (dispneia) + CAT Score + exacerbações → grupos A, B, E
- FRC: tabagismo (principal), exposição ocupacional, biomassa

# Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI)

## Manifestações Clínicas

- Dispneia progressiva de esforço (principal queixa)
- Tosse seca persistente
- Crepitações em velcro bibasais: som de velcro sendo descolado, inspiratório, tardio
- Baqueteamento digital (hipocratismo): > 50% dos casos de FPI
- Cianose central nos casos avançados
- Hipertensão pulmonar secundária: B2 hiperfonética, cor pulmonale
- Padrão restritivo na espirometria: CVF < 80%, CPT < 80%, VEF<sub>1</sub>/CVF normal ou elevada

## Diagnóstico e Diferencial

- TCAR (tomografia de alta resolução): padrão UIP — opacidades reticulares e em favo de mel com predomínio basal e subpleural, bronquiectasias de tração
- Diferencial: DPOC (obstrutivo), ICC (crepitações + congestão), sarcoidose, pneumonite de hipersensibilidade
- FPI vs DPOC: espirometria diferencia — FPI = restritivo; DPOC = obstrutivo
- Espirometria na FPI: CVF reduzida, VEF<sub>1</sub>/CVF > 0,70
- Biópsia pulmonar cirúrgica: confirma diagnóstico quando TCAR inconclusivo



## SIMULAÇÃO 8 — Caso Clínico

**CASO:** JMB, 70 anos, tabagista de 50 anos/maço, refere dispneia aos médios esforços e tosse com expectoração amarelada matinal há 5 anos, com piora nos últimos 3 meses. Ao exame: tórax em tonel, hiperfonese difusa, sibilos expiratórios, SpO<sub>2</sub> 90%.

### O que o examinador pode pedir:

1. Qual o diagnóstico mais provável? A qual fenótipo clínico este paciente se enquadra?
2. Quais perguntas adicionais você faria para quantificar tabagismo e exacerbações prévias?
3. Solicite a espirometria e descreva o padrão esperado.
4. Como classificar pelo GOLD com base em  $VEF_1 = 45\%$  do predito?
5. Diferencie os achados de ausculta do DPOC com os da Fibrose Pulmonar Idiopática.



# Aspectos Clínicos das Síndromes Pleurais

Derrame pleural · Pneumotórax · Empiema · Toracocentese

# Síndromes Pleurais — Derrame Pleural

## Achados Semiológicos

- Expansibilidade torácica reduzida no lado acometido
- Frêmito tóraco-vocal (FTV) abolido
- Percussão: macicez hídrica (sinal de Skoda: timpanismo acima do derrame)
- Ausculta: murmúrio vesicular abolido, egofonia (voz do bode) na transição
- Desvio do mediastino para o lado OPOSTO em grandes derrames
- Atrito pleural: sinal precoce antes de grande acúmulo de líquido

## Características do Líquido Pleural

- Transudato: ICC, cirrose, síndrome nefrótica | Proteínas < 3g/dL; LDH < 200 UI/L
- Exsudato: Critérios de Light (basta 1): LP proteína/S proteína > 0,5; LP LDH/S LDH > 0,6; LP LDH > 2/3 LSN sérico
- Exsudato: infecção, neoplasia, TB, collagenoses
- Hemotórax: LP/S hematócrito > 0,5
- Quilotórax: LP triglicerídeos > 110 mg/dL
- Empiema: pus macroscópico; pH < 7,2; glicose < 60; bactérias ao Gram

# Pneumotórax e Outras Síndromes

## Pneumotórax

- Espontâneo primário: jovem, alto, magro, sem doença pulmonar — dor pleurítica súbita + dispneia
- Espontâneo secundário: DPOC, FPI, TB — maior gravidade
- Achados: expansibilidade reduzida, FTV abolido, timpanismo, MV abolido
- Pneumotórax hipertensivo: desvio da traqueia para lado OPOSTO, hipotensão, estase jugular, dispneia extrema — URGÊNCIA
- Hemopneumotórax: macicez na base + timpanismo no ápice

## Toracocentese — Indicações e Técnica

- Indicações diagnósticas: derrame de etiologia desconhecida > 10 mm na DL
- Indicações terapêuticas: dispneia associada a grande derrame
- Local: triângulo de segurança (linha axilar posterior, linha axilar anterior, nível da 5ª costela)
- Técnica: borda superior da costela (evitar feixe vaso-nervoso do bordo inferior)
- Coleta: pH, proteínas, LDH, glicose, Gram, cultura, citologia, ADA (se suspeita de TB)
- Contraindicação relativa: coagulopatia grave, anticoagulação



## SIMULAÇÃO 9 — Caso Clínico

**CASO:** TAO, 55 anos, feminino, com neoplasia de mama em tratamento. Dispneia progressiva há 1 semana. Ao exame físico do tórax: expansibilidade reduzida à direita, macicez à percussão em 2/3 inferiores do hemitórax D, murmúrio vesicular abolido, egofonia na transição.

### O que o examinador pode pedir:

1. Identifique a síndrome pleural e descreva os achados que a caracterizam.
2. Quais perguntas adicionais você faria para identificar a etiologia (neoplasia, IC, infecção)?
3. Solicite os exames para diferenciação transudato x exsudato (aplique Critérios de Light).
4. Descreva o local e a técnica de realização da toracocentese.
5. Qual o papel da ADA neste líquido pleural?



# Síndromes Pulmonares e Brônquicas

Condensação · Atelectasia · Cavitação · Obstrutiva · Semiologia comparada

# Síndromes Pulmonares — Achados Comparativos

| Síndrome                | Expansibilidade | FTV                           | Percussão                 | Ausulta                                       |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Condensação (Pneumonia) | ↓ ipsilateral   | ↑ (aumentado)                 | Submaciça/macicez         | Crepitações, broncofonia, pectorilóquia áfona |
| Atelectasia             | ↓ ↓ ipsilateral | ↓ ou abolido                  | Macicez                   | MV ↓ ou abolido                               |
| Derrame Pleural         | ↓ ipsilateral   | Abolido                       | Macicez hídrica           | MV abolido, egofonia na transição             |
| Pneumotórax             | ↓ ipsilateral   | Abolido                       | Timpanismo                | MV abolido                                    |
| Cavitação (TB)          | Variável        | ↑ (se rodeada de condensação) | Timpanismo (voz anfórica) | Sopro cavitário, pectorilóquia                |
| Enfisema / DPOC         | ↓ ↓ bilateral   | ↓ bilateral                   | Hipersonoridade           | MV ↓ global, sibilos expiratórios             |

# Síndromes Brônquicas — Clínica e Achados

## Síndrome Obstrutiva Brônquica

- Causa: broncoespasmo (asma, DPOC), secreção brônquica excessiva
- Sibilos: ruído musical, expiratório (predomínio), pode ser inspiratório nas crises graves
- Roncos: ruídos de baixa frequência — secreção nas grandes vias aéreas
- Expiração prolongada (tempo expiratório > 3 seg)
- Asma brônquica: sibilância difusa, reversível ao broncodilatador, sem febre
- Bronquite aguda: sibilância focal, tosse produtiva, febre
- Crise asmática grave: tórax silencioso (obstrução total) — sinal de alerta

## Síndrome de Condensação (Pneumonia)

- Fisiopatologia: alveolite exsudativa — alvéolos preenchidos por exsudato inflamatório, mantendo brônquio pérvio
- Crepitações finas (inspiratórias, tardias): som de cabelo friccionado perto do ouvido
- Broncofonia: voz mais nítida e ressonante (diga 33)
- Pectorilóquia áfona: sussurro 'pix' ouvido claramente — área de condensação
- Sopro tubário: substituição do MV pelo sopro laringotraqueal transmitido — consolida o diagnóstico de condensação
- Diferencial: atelectasia (FTV reduzido, sem sopro tubário), derrame (macicez hídrica)



## SIMULAÇÃO 10 — Caso Clínico

**CASO:** Estação prática: o examinador apresenta um paciente com febre há 4 dias, tosse produtiva e dor pleurítica no hemitórax direito. Ao exame: temperatura 38,8°C, FR 26 irpm, SpO<sub>2</sub> 93%.

### O que o examinador pode pedir:

1. Realize o exame físico do tórax (inspeção → palpação → percussão → ausculta) descrevendo o passo a passo em voz alta.
2. Identifique a síndrome pulmonar presente com base nos achados.
3. Diferencie clinicamente pneumonia lobar de derrame pleural paraneumônico.
4. Solicite os exames necessários (RX tórax, hemograma, culturas).
5. Quais perguntas você faria para estratificar a gravidade (PSI/CURB-65)?



# Aspectos Clínicos das Anemias

Classificação morfológica · Ferropriva · Megaloblástica · Hemolítica

# Anemias — Clínica e Classificação Morfológica

## Manifestações Clínicas Gerais

- Palidez cutâneo-mucosa (conjuntiva palpebral, palma das mãos, leito ungueal)
- Astenia, fadiga, dispneia aos esforços
- Palpitações, taquicardia, sopro sistólico funcional (hipercirculatório)
- Cefaleia, déficit de concentração
- Sinais específicos: icterícia (hemolítica), glossite (ferropriva/megaloblástica), coiloníquia (ferropriva)

## Classificação Morfológica

- Microcítica hipocromica (VCM < 80 fL, HCM < 27 pg): ferropriva, talassemia, anemia sideroblástica, inflamatória crônica
- Normocítica normocrômica (VCM 80–100 fL): doença crônica, aplasia, hemolítica (início), insuficiência renal
- Macrocítica (VCM > 100 fL): megaloblástica (B12, folato), hepatopatia, hipotireoidismo, uso de AZT/metotrexato
- RDW: indica anisocitose — diferencia ferropriva (↑ RDW) de talassemia (RDW normal)

# Diagnóstico Diferencial das Anemias — Exames Laboratoriais

| Parâmetro     | Ferropriva    | Doença Crônica | B12/Folato    | Hemolítica |
|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|
| VCM           | ↓ Microcítica | N ou ↓         | ↑ Macrocítica | N ou ↑     |
| Reticulócitos | ↓             | ↓              | ↓             | ↑ ↑        |
| Ferritina     | ↓ ↓           | N ou ↑         | N             | N          |
| Ferro sérico  | ↓             | ↓              | N             | N          |
| CTLF          | ↑             | ↓ ou N         | N             | N          |
| Saturação Tf  | ↓ (< 16%)     | ↓ ou N         | N             | N          |
| Bilirrubina   | N             | N              | N             | ↑ indireta |
| LDH           | N             | N              | ↑ ↑           | ↑          |
| Haptoglobina  | N             | N              | N             | ↓ ↓        |



## SIMULAÇÃO 11 — Caso Clínico

**CASO:** LMO, 28 anos, feminina, com queixa de cansaço progressivo há 3 meses, irregularidade menstrual com fluxo intenso. Exame físico: palidez conjuntival e palmar, coiloníquia, mucosa oral seca e atrófica. Hemograma: Hb = 8,2 g/dL, VCM = 68 fL, HCM = 22 pg, RDW = 16,2%.

### O que o examinador pode pedir:

1. Classifique a anemia morfollogicamente e aponte o diagnóstico mais provável.
2. Quais perguntas adicionais você faria na anamnese (alimentação, perdas, gestação)?
3. Quais exames solicitaria para confirmar o diagnóstico e excluir diagnósticos diferenciais?
4. Como diferenciar anemia ferropriva de anemia de doença crônica pelos exames laboratoriais?
5. Identifique os achados ao exame físico compatíveis com a síndrome ferropriva.



# Manifestações Clínicas das Arboviroses

Dengue · Zika · Chikungunya · Diagnóstico diferencial

# Dengue — Fases e Critérios de Alarme

## Fases da Dengue

- Fase Febril (dias 1–3): febre alta (39–40°C), cefaleia, mialgia, artralgia, dor retroorbitária, exantema maculopapular
- Sinal do laço: positivo quando  $\geq 20$  petéquias por polegada quadrada após 5 min com manguito na pressão média
- Fase Crítica (dias 4–6): defervescência, extravasamento plasmático — choque, derrame pleural, ascite
- Fase de Recuperação (dias 6–7): reabsorção de líquidos, bradicardia, exantema de resolução
- Dengue Grave: choque, hemorragias graves, disfunção orgânica

## Critérios de Alarme (hospitalização obrigatória)

- Dor abdominal intensa e contínua ou à palpação
- Vômitos persistentes
- Acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural/pericárdico)
- Hipotensão postural / lipotimia
- Letargia ou irritabilidade
- Hepatomegalia  $> 2$  cm abaixo do rebordo costal
- Sangramento de mucosas
- Plaquetas  $\leq 20.000 / \text{mm}^3$  (mesmo sem sangramento)
- Hematócrito elevado (hemoconcentração  $\geq 20\%$ )

# Zika e Chikungunya — Diagnóstico Diferencial

## Zika

- Exantema maculopapular pruriginoso (mais intenso que dengue, mais leve que chikungunya)
- Febre baixa ou ausente
- Conjuntivite não purulenta bilateral
- Artralgia leve a moderada (mãos e pés)
- Complicações: síndrome de Guillain-Barré, microcefalia fetal (transmissão vertical)
- Diagnóstico: RT-PCR (viremia curta) ou sorologia IgM
- RT-PCR positivo até 5 dias do início dos sintomas no sangue

## Chikungunya

- Artralgia intensa e incapacitante: poliartralgia bilateral e simétrica em mãos, punhos, tornozelos (diferencial da dengue)
- Febre de início súbito ( $> 38,5^{\circ}\text{C}$ )
- Exantema maculopapular em tronco e membros
- Fase aguda: até 10 dias | Subaguda: artrite persistente (10 dias – 3 meses) | Crônica:  $> 3$  meses
- Diagnóstico: RT-PCR (fase aguda  $< 8$  dias) ou IgM (fase subaguda/crônica)
- Grupo de risco: neonatos (via periparto), idosos, imunossuprimidos

# Diagnóstico Diferencial das Arboviroses

| Característica    | Dengue                    | Zika                         | Chikungunya            |
|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| Febre             | Alta (39–40°C)            | Baixa ou ausente             | Alta (> 38,5°C)        |
| Artralgia         | Leve                      | Leve-moderada                | Intensa, incapacitante |
| Exantema          | Maculopapular (resolução) | Pruriginoso, precoce         | Maculopapular          |
| Conjuntivite      | Ausente                   | Não purulenta                | Ausente                |
| Plaquetopenia     | Sim (marcante)            | Leve                         | Leve                   |
| Hemorragia        | Sim (grave)               | Raro                         | Raro                   |
| Complicação chave | Choque/sangramento        | Guillain-Barré, microcefalia | Artrite crônica        |



## SIMULAÇÃO 12 — Caso Clínico

**CASO:** ASF, 32 anos, feminina, grávida de 12 semanas. Queixa de febre baixa há 3 dias (37,8°C), exantema pruriginoso em tronco e membros, conjuntivite bilateral e artralgia leve em punhos. Nega sangramento. Sinal do laço negativo.

### O que o examinador pode pedir:

1. Qual o diagnóstico diferencial prioritário nesta gestante e por quê?
2. Quais perguntas adicionais você faria (viagens, contato, sintomas do parceiro)?
3. Realize o sinal do laço e descreva a técnica correta.
4. Solicite os exames corretos para o diagnóstico diferencial das arboviroses.
5. Quais as implicações do diagnóstico confirmado de Zika na gestação e como orientar a paciente?

# Hepatoesplenomegalia, Linfadenopatia, Linfoma e Discromias

Técnica de exame · Características semiológicas · Linfoma · Discromias cutâneas

# Exame do Fígado e Baço — Técnica

## Fígado — Palpação e Percussão

- Percussão: delimitar borda superior (maciez hepática — normalmente 6ª costela na LMC) e inferior (maciez se abaixo do RCD)
- Palpação bimanual: início na FID, avança em direção ao RCD com a inspiração — palpar borda inferior
- Características a descrever: consistência (normal = mole-elástica; cirrose = endurecida), superfície (lisa x nodular), bordas (cortante x romba), dolorosa?
- Hepatomegalia: borda hepática > 2 cm abaixo do RCD na LMC
- Percussão do espaço de Traube (timpanismo basal E): abolição sugere esplenomegalia

## Baço — Técnica de Palpação

- Decúbito dorsal + lateral direito com joelhos fletidos
- Mão esquerda sob o gradil costal posterior E para elevar o baço
- Palpação suave com mão direita, início na FID
- Esplenomegalia: palpável abaixo do RCE
- Gradação: grau I (até 5 cm), II (5–10 cm), III (10–15 cm), IV (> 15 cm) abaixo do RCE
- Sinal de Schuster: percussão do espaço de Traube — timpanismo abolido em jejum sugere esplenomegalia

# Linfadenopatia e Linfoma — Aspectos Clínicos

## Características Semiológicas do Linfonodo

- Tamanho: > 1 cm axila/inguinal; > 0,5 cm cervical — patológico
- Consistência: borrachosa = linfoma; pétreo/endurecido = metástase; mole e flutuante = abscesso
- Mobilidade: fixo (malignidade, inflamação crônica) vs móvel (reacional)
- Coalescência: linfonodos fundidos = inflamação/neoplasia
- Fistulização: TB ganglionar, actinomicose
- Doloroso: linfonodomegalia reacional (infecção aguda) — indolor sugere malignidade

## Linfoma — Diferenças Hodgkin × Não-Hodgkin

- Linfoma de Hodgkin: jovens adultos (20–35 anos), adenomegalia cervical ou mediastinal, progressão contígua, célula de Reed-Sternberg, sintomas B (febre, sudorese noturna, perda >10% peso)
- Linfoma Não-Hodgkin: mais prevalente, todas idades, adenomegalia periférica difusa ou extranodal, progressão não contígua
- Sintomas B: presença = pior prognóstico
- Sinal de Pel-Ebstein: febre ciclante (Hodgkin)
- Exames: LDH, beta-2-microglobulina, biópsia excisional (não punção aspirativa)

# Discromias Cutâneas — Aspectos Clínicos

## Hipocromias e Acromias

- Vitiligo: manchas acrômicas bem delimitadas, bordas hiperpigmentadas, simétrico, perda de melanócitos por autoimunidade
- Pitíriase versicolor: manchas hipocrômicas ou hipercrômicas com descamação furfurácea, KOH positivo (espaguete e almôndegas)
- Hanseníase: mancha hipocrômica com anestesia (redução/perda de sensibilidade), bordas bem definidas — diagnóstico clínico
- Albinismo: ausência congênita de melanina, fotofobia, nistagmo

## Hipercromias e Outras

- Melasma: hiperpigmentação simétrica face (fronte, maçãs do rosto), relacionada a estrogênio, sol, gravidez
- Acantose Nigricans: hiperpigmentação e espessamento aveludado em flexuras (pescoço, axilas, inguinal) — resistência à insulina, DM2, síndrome metabólica, adenocarcinoma gástrico (paraneoplásico)
- Icterícia: impregnação de bilirrubina — esclerótica, pele, mucosas ( $> 2 \text{ mg/dL}$  → clínica)
- Cianose central: língua, mucosas —  $\text{SpO}_2 < 85\%$ ; cianose periférica: extremidades
- Eritema nodoso: nódulos dolorosos na face anterior das pernas — reação de hipersensibilidade (TB, sarcoidose, estreptococo)



## SIMULAÇÃO 13 — Caso Clínico

**CASO:** CMF, 26 anos, masculino, com adenomegalia cervical bilateral indolor há 3 meses. Nega infecção recente. Apresenta febre intermitente (ciclos de 10 dias), sudorese noturna profusa e perda de 6 kg em 2 meses. Ao exame: cadeias cervicais, axilares e inguinais comprometidas; consistência borrachosa, sem coalescência nem fistulização. Baço palpável a 4 cm do RCE.

### O que o examinador pode pedir:

1. Quais achados indicam malignidade nesta linfadenopatia? Quais perguntas completariam a anamnese?
2. Identifique os sintomas B e seu valor prognóstico.
3. O quadro é mais sugestivo de Linfoma de Hodgkin ou Não-Hodgkin? Justifique.
4. Demonstre a técnica de palpação do baço e classifique o grau de esplenomegalia.
5. Solicite os exames de investigação (hemograma, LDH, beta-2-microglobulina, biópsia) e comente por que a biópsia excisional é preferível à punção.

# REVISÃO OSCE — Semiologia Médica

**Boa prova a todos!** 

Dúvidas? Procure a monitoria antes da prova!

13 tópicos · Sinais vitais · Exame físico dirigido · Casos clínicos simulados